

בזמן הלידה

- + תמוך בפריניאום בעת יציאת הראש.
- + אם שק השכיר נמצא שלם סביב ראש היילוד, יש לפקוע אותו בעדינות.
- + לאחר יציאת הראש ודא כי חבל הטבור אינו כרוך סביב צוואר היילוד.
- + אם יש צורך בשאיבת נוזלים אצל היילוד, יש לשאוב קודם מחלל הפה ואחרי כן מהאף.

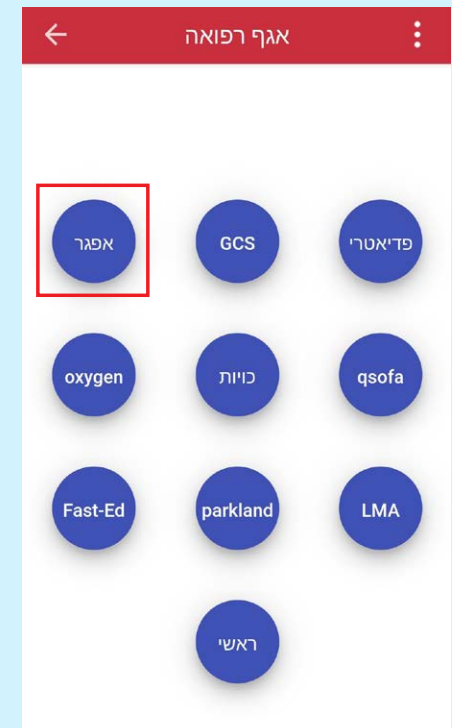
לאחר הלידה

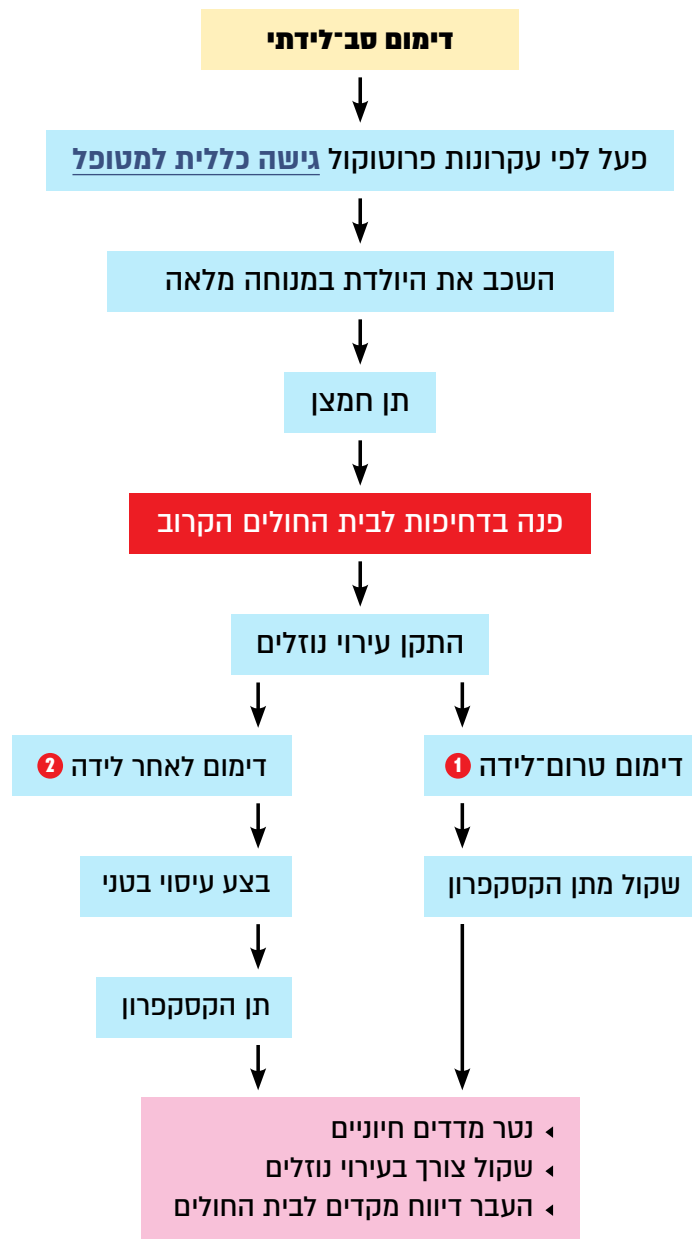
- + יבש את היילוד ועטוף אותו, רצוי להשתמש בכיסוי הייעודי ככל שמתאפשר. שמור על סביבה חמה.
- + השכב את היילוד על האם.
- + חתוך את חבל הטבור לאחר 1-3 דקות מהלידה.
- + ודא תחילת נשימה ספונטנית של היילוד תוך 30 שניות מהלידה.
- + **שקול צורך במעבר לפרוטוקול הטיפול המידי ביילוד.**
- + בצע הערכת APGAR ראשונה דקה לאחר הלידה, והערכה שנייה 5 דקות לאחר הלידה.
- + אין צורך להמתין ללידת השליה לפני תחילת הפינוי לבית החולים.
- + **אין למשוך את חבל הטבור בניסיון ליילד את השליה.**
- + בסיום הלידה יש ליישר את רגלי היולדת, להניח פד סטרילי באזור הפריניאום ולעודד את היולדת להניק את היילוד.

מדד	ציון: 0	1	2
מראה	כחלון כללי, חיוור	כחלון בגפיים	צבע ורוד
דופק	ללא דופק	פחות מ־100 בדקה	מעל 100 בדקה
העוויה	ללא תגובה	העוויה קלה/בכי חלש	בכי חזק
פעילות	רפיון כללי	טונוס חלקי בגפיים	טונוס חזק – כיפוף ידיים ורגליים
נשימות	אינו נושם	נשימות חלשות/לא סדירות	נשימות טובות וסדירות/בכי

אין לבצע בדיקה גינלית ליולדת.

אין לאפשר ליולדת לעמוד או ללכת עצמאית (לרבות לשירותים). יש לוודא כי היולדת נמצאת כל הזמן במנח ישיבה או שכיבה. אם היא מסרבת – יש לתעד זאת בדו"ח הרפואה.





1 סיבות לדימום טרום־לידתי

- + שליית פתח (placenta Previa).
- + היפרדות שליה (Abruptio placenta).
- + Vasa Previa.

2 סיבות לדימום לאחר לידה

- + אטוניה של הרחם (היעדר התכווצויות ברחם).
- + הפרעות קרישה.
- + היפרדות שליה מוקדמת.
- + קרע של שריר הרחם.
- + שליה נעוצה (placenta accreta).

דימום וגנילי מסיבי לאחר לידה

- + הגדרתו – מעל 500 ml דם (בהערכה).
- + סימנים קליניים – טכיקרדיה, חיוורון, הזעה, מילוי קפילרי איטי.
- + טיפול –
- עיסוי הבטן (מעודד התכווצות הרחם).
- מתן הקסקפרון (1 gr) בהזלפה במשך 10 דקות (אין לעכב פינוי לצורך מתן הקסקפרון) או בכוש איטי.

! שימו לב!

יש להתייחס לכל דימום וגנילי במהלך הטרימסטר השלישי כמצב חירום מסכן חיים.